

Somatyczne *doświadczenie afektu*

Emocja powstaje w ciele, zanim zostanie nazwana. Gdy pacjent „mówi o” uczuciu, a nie czuje go, droga powrotna prowadzi przez ciało: gdzie to jest, jaki ma kształt, ciężar, ruch.

CZAS: 25 min Gdy pacjent „mówi o” emocji, nie czuje jej; izolacja afektu

ŹRÓDŁO: Fosha (2000); Ogden i in. (2006)

JAK UŻYWAĆ

Przenosisz pacjenta z warstwy racjonalizacji do warstwy doświadczenia przez kontakt z ciałem. Zatrzymujesz intelektualizację („mówi Pani o smutku — a *czuje* go teraz?”), zapraszasz do ciała („gdzie to jest? w klatce, brzuchu, gardle?”), prosisz o opis sensoryczny (kształt, ciężar, temperatura, ruch) i czekasz. Obserwujesz mikroznaki: oddech, napięcie, kolor twarzy, łzy. Gdy afekt wybrzmiewa — jesteś z pacjentem, nie przerywasz.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Afekt jest zjawiskiem psychosomatycznym — powstaje w ciele przed językiem (markery somatyczne, Damasio). Pacjent z obronami intelektualnymi opisuje emocje bez ich czucia — to znak izolacji afektu, a odblokowanie następuje przez powrót do ciała. Ciało ma własne archiwum: nosi ślady nieprzetworzonych emocji jako chroniczne napięcia i bóle; kontakt z nimi pozwala afektowi **wybrzmieć** i zamknąć przerwany cykl (Fosha; Ogden). U pacjentów po traumie praca somatyczna wymaga zaawansowanego szkolenia.

01 Sekwencja pracy z ciałem

- ① **Zatrzymaj intelektualizację** — „a czuje Pani to teraz?”
- ② **Zaproś do ciała** — „gdzie to jest? klatka, brzuch, gardło?”
- ③ **Opis sensoryczny** — kształt, ciężar, temperatura, ruch
- ④ **Czekaj** — eksploracja somatyczna wymaga czasu, nie przyspieszaj
- ⑤ **Obserwuj mikroznaki** — oddech, napięcie, kolor, łzy
- ⑥ **Bądź przy wybrzmiewaniu** — afekt potrzebuje przestrzeni, nie słów

02 Zanotuj sygnały somatyczne tego pacjenta

Gdzie u tego pacjenta lokuje się afekt? Jakie sygnały ciała pojawiają się przy trudnych tematach?

SYGNAŁY SOMATYCZNE

03 ✱ Po wybrzmieniu

Gdy afekt wybrzmiał (łzy, drżenie, ciepło), zapytaj o stan ciała: „jak ciało teraz? Co się zmieniło?”. Po afekcie często pojawia się ulga i spokój. Zapisz, co pacjent zauważył.

CO ZMieniŁO SIĘ PO WYBRZMIENIU

04 ✕ Granica: dysocjacja

Jeśli pacjent dysocjuje (pustka, dystans, „gdzieś odpływa”) — **przerwij** i wróć do ugruntowania: kontakt stóp z podłogą, wzrok na konkretnym obiekcie, nazwanie tego, co w pokoju. Dysocjacja sygnalizuje, że afekt jest zbyt intensywny i potrzebna jest regulacja.

MÓJ PLAN UGRUNTOWANIA, GDYBY POJAWIŁA SIĘ DYSOCJACJA

Klucz: „gdzie to jest w ciele?” to jedno z najsilniejszych pytań w STPP — przenosi pacjenta z racjonalizacji do doświadczenia. Ale musi paść w odpowiednim momencie: gdy sojusz jest zbudowany i pacjent ufa procesowi. Zbyt wcześnie wywołuje obronną niechęć („nie wiem, co Pan ma na myśli”).